

מיומנויות לשיפור נשימה

ניקוז חזה במחט (Needle Application: NA)

- **ההתוויות לביצוע** - פנאומוטורקס בלחץ (חזה אוויר בלחץ).
- בפנאומוטורקס בלחץ רואים גודש בווריד הצוואר, רעב לחמצן, כשל המודינמי. בהאזנה - כניסת אוויר מופחתת או ללא כניסת אוויר כלל, הסטת הקנה לצד השני.
- אמפיזמה - בית חזה נפוח ולא משתתף בתהליך הנשימה, אפשר יהיה להרגיש את האוויר מתחת לעור. אפשר לראות תמונה קלינית סוערת.
- **ציוד נדרש** - ונפולון G14 או מחט מסוג TPAK
- מחליטים איזה צד הוא הפגוע לפי האנמנזה, סיפור מקרה והבדיקה הפיזיקלית.
- חשוב לציין שניקוז חזה במחט (needle application: NA) הוא טיפול זמני, טיפול סימפטומטי, אינו פותר את הבעיה - אוויר ימשיך להיכנס לתוך בית החזה.

שימוש בוונפולון או במחט ייעודית ל-NA

לוקחים ונפולון, מוצאים את המקום המתאים (מרווח בין צלעי 2-3, קו אמצע בריחי), מותחים אותו, מחטאים ומחדירים את הונפולון ב־90 מעלות עד הסוף, ולבסוף מוציאים את המחט. צריך להישמע קול יציאת האוויר בלחץ מהחזה.

שסתום אשרמן



תמונה 25.38 שסתום אשרמן

- שסתום אשרמן הוא שסתום חד־כיווני המאפשר יציאה של אוויר דרך נקב בחזה אך אינו מאפשר כניסה של אוויר מבחוץ פנימה.
- השסתום מורכב מתחבושת דביקה שבמרכזה פד גזה.
- מצידו החיצוני של השסתום נמצא השסתום המורכב מצינור גומי גמיש שמאפשר רק יציאה של אוויר מצידו הפנימי של השסתום לכיוון צידו החיצוני.
- מניחים את שסתום אשרמן בכל פצע חודר בחזה או בגב.
- לאחר הנחת השסתום יש להמשיך לעקוב אחר מצב הנפגע.
- בכל מקרה של הידרדרות במצב הנפגע יש להוריד את השסתום.

מימנויות קיבוע

אחיזת ראש לקיבוע

בנפגע טראומה או נפגע החשוד כנפגע עמוד שדרה או עמוד שדרה צווארי מבצעים אחיזת ראש ידנית לנפגע למניעת תזוזתו כדי למנוע תזוזת הראש וגרימת נזק לחוט שדרה צווארי. זאת הפעולה הראשונה שיש לבצע לאחר וידוא בטיחות הצוות. חשיבות אחיזת הראש היא מניעת תזוזת ראשו של הנפגע הן לצדדים הן אחורה וקדימה, ובכך שומרים על עמוד השדרה הצווארי ומונעים פגיעה נוספת אם יש חבלה.

- איש הצוות המבצע את אחיזת הראש יתמקם מאחורי ראשו של הנפגע, בין אם הוא שוכב ובין אם הוא יושב, למשל בתוך רכב.
- יש לאחוז בשתי ידיים את ראשו של הנפגע באזור האוזניים, אך אין לחסום את האוזניים כדי שהנפגע יוכל לשמוע את המתרחש סביבו.
- יש לאחוז את ראש הנפגע בעדינות אך ביציבות תוך כדי מתיחה קלה של הראש. מתיחה זו דרושה כדי למתוח מעט ובעדינות את חוליות הצוואר של הנפגע.



תמונה 25.46 צווארון פילדלפיה

צווארון פילדלפיה

יש 2 גדלים של צווארון: צווארון מבוגרים מתכוון וצווארון ילדים. לצווארון הילדים שני חלקים: חלק קדמי עם פתח קדימה ורווח מותאם לסנטר, וכן חלק אחורי המצויד ברצועות סקוץ' לשם הצמדתו לחלק הקדמי. לכל חלק יש צד עליון וצד תחתון. הצד העליון צר והצד התחתון רחב (רשום על הצווארון).

הצווארון מונע את תנועת ההנאה ("כן") של הראש - תנועת הראש למעלה ומטה, אולם הוא אינו מונע את תנועת הראש לצדדים ("לא").

הנחת צווארון פילדלפיה בנפגע שוכב

- בעת קיבוע ראשו של הנפגע שומרים כל הזמן על קיבוע הראש ומניעת תזוזתו.
- מניחים תחילה את החלק האחורי של הצווארון ואחר כך את חלקו הקדמי.
- החלק האחורי של הצווארון גמיש מאוד, ולכן אפשר ליישר אותו ולמתוח את רצועות הסקוץ'.
- המטפל הראשון מחזיק את ראש הנפגע ומונע ממנו לזוז.
- המטפל השני מיישר את החלק האחורי של הצווארון, מכניס אותו בזירות מצד אחד של הצוואר ומתחתיו עד שהצווארון נמצא סימטרית משני צידי צווארו של הנפגע.
- המטפל השני מניח את חלקו הקדמי של הצווארון ומהדק את רצועות הסקוץ' אל החלק הקדמי.
- במשך כל הזמן הזה ראשו של הנפגע צריך להיות מקובע.